



Paciente	Geni Pinheiro da Silva	Atendimento	13.643.294
Idade	95a 11m 7d	Prontuário	2064165
Sexo	Feminino	Dt. Entrada	27/04/2023 18:46:58
Convênio	MedSenior - Samedil Serviços de Atendimento Médico SA	Leito	UI332
Médico Responsável	Dr. Carlos Henrique Reis Esselin Rassi (CRM 22575)		

Histórico da Internação: Motivo da internação: - Crise convulsiva em 25/04/2023 ---Coleções subdurais bilaterais (hemato-higromas) - tratamento conservador inicial --- Coleção subdural esquerda com efeito compressivo >> PO (30/04/23) Drenagem de coleção subdural esquerda - Hiponatremia hipolêmica, melhorada pós hidratação - Leucocitose+ PCR elevado + EAS infeccioso + em contexto de idosa com alt do nível de consciência - ITU?, em tratamento Antibióticos: Atual: Rocefin 27/04/2023 Culturas: 27/04:Hemoculturas: parciais negativas 27/04: Urocultura: negativa. Resumo da admissão: " Paciente de 95 anos, encaminhada do PS Medsênior devido a quadro de crise convulsiva há dois dias associado a achado de coleções subdurais bilaterais. Filho descreve que há pelo 6 anos, devido internação prolongada secundária a complicação de coledocolitíase, paciente ficou mais restrita ao leito, devido a redução de massa muscular, mesmo com fisioterapia, não conseguiu reabilitar completamente. Informa que nos últimos 7 dias paciente vem se apresentando mais apatia e prostração, culminando com crise convulsiva há dois dias. Antecedentes pessoais: -História de hematoma subdural espontâneo prévio- há + 10 anos - Coledocolitíase há 6 anos > Com internação prolongada, determinando sarcopenia. -Idosa frágil, com LPP grau II trocânticas -Relato de uso de puran há anos atrás - filho refere que tinha problema na tireóide - SIC -Passado de depressão, em contexto de luto (falecimento do marido), filho foi desmamando por conta própria na pandemia, onde perdeu seguimento com médicos, e refere que ela ficou bem de toda forma - SIC. -Fratura previa em coluna, com tratamento conservador - SIC filho Funcionalidade prévia: Totalmente dependente - devido a mobilidade e sarcopenia (transferência com ajuda, ficava sentada 50% do tempo em casa), alimentação supervisionada por filho. Cognição: Relato de lentificação progressiva, com confusão mental por um período ao acordar, e há 1 ano, com maior dificuldade para memória de curto prazo, mas leve, sem alterações com memória retrógrada. Sem investigação de síndrome demencial a nível ambulatorial e fora de contexto hospitalar. Imagem: Realizou tomografia de crânio no PA de origem, evidenciado coleções subdurais crônicas bilaterais, mais espesso em lado esquerdo, com aspecto de HIGROMA. Apresenta ligeiro efeito compressivo sobre parenquima cerebral. Cisternas patentes . Coleções subdurais com densidade discretamente superior à líquórica frontoparietais bilaterais, com lâmina líquida de 1,6 cm à esquerda e 0,7 cm à direita. Linha média centrada. TC de crânio SC - 30/04: Sinais de abordagem cirúrgica prévia com orifícios de trepanação frontais bilaterais. Higromas subdurais frontoparietais bilaterais. Sinais de redução volumétrica do parênquima encefálico e degeneração aterosclerótica dos vasos intracranianos. Hipodensidades da substância branca periventricular bi-hemisférica, habitualmente relacionadas a gliose e/ou rarefação de mielina. Pequena calcificação junto ao clivus, podendo representar pequeno meningioma calcificado ou calcificação dural. EEG (29/04/23): Desorganização difusa e moderada da atividade de base.Comentários: A desorganização da atividade de base decorreu do aumento no teor de ondas lentas e carência de ritmos rápidos tal achado se correlaciona com encefalopatia de etiologia inespecífica. NEUROCIRURGIA - 03/05/23: Conduta: - Manter medidas de cuidados clínicos iniciais para tratamento de ITU, hidratação e anticonvulsivante. Tentativa de progressão de dieta. Considerar SNE se não progressão ou aceitação de dieta via oral. - Neste presente contexto, não há cuidados adicionais desta especialidade no momento. Retirar pontos após 10 dias de cirurgia. Ficamos à disposição. Planos e metas: - Dor abdominal a/e - Melhor controle algico, antes da desospitalização. Medsenior ciente em acompanhamento dos ajustes antes da alta. Conduta: - Programação de alta provável hoje - 15/05/23, remoção pelo plano de saúde, com fisioterapia 5x/semana e acompanhamento médico domiciliar. - Acompanhamento conjunto com ECP. - Acompanhamento e cuidados multidisciplinares.

	Uso do SAME
Diagnóstico Principal de Alta: Crise convulsiva	CID
Outros Diagnósticos:	CID
	CID
	CID
	CID
Procedimentos Cirúrgicos	Data





HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS

Resumo de Alta



13643294

Paciente	Geni Pinheiro da Silva	Atendimento	13.643.294
Idade	95a 11m 7d	Prontuário	2064165
Sexo	Feminino	Dt. Entrada	27/04/2023 18:46:58
Convênio	MedSenior - Samedil Serviços de Atendimento Médico SA	Leito	UI332
Médico Responsável	Dr. Carlos Henrique Reis Esselin Rassi (CRM 22575)		

Hematoma subdural crônico - tratamento cirúrgico 30/04/2023

Procedimentos Invasivos ou Exames com Sedação/Anestesia Realizados Data

Intercorrências: Não

Principais Medicações Administradas:

O(a) Sr.(a) foi medicado(a) com antibiótico, é importante mantê-lo pelo período fixado: Não

Medição de alta? Não

Restrição de atividade física: Não

Dieta Especial: Não

Outras orientações:

Tipo de Saída: Alta (Assistencia Domiciliar)

Motivo da Saída: Melhorado

Importante: Em caso de aparecimento de novos sinais/sintomas procure o seu médico ou retorne ao Hospital Siro Libanês trazendo esta ficha

Data da Alta: 15/05/2023 14:00

Nome e CRM legível ou carimbo

Dr. Matheus Marques Franca
CRM-DF:17096





13643294

Paciente	Geni Pinheiro da Silva	Atendimento	13.643.294
Nascimento	08/06/1927	Prontuário	2.064.165
Sexo	F	Dt. Entrada	27/04/2023
Convênio	MedSenior - Samedil Serviços de Atendimento Médico SA	Leito	UI332
Médico Responsável	Dr. Carlos Henrique Reis Esselin Rassi (CRM 22575)		

Prescrição Médica

USO ORAL

ALLEGRA 120 MG ----- Tomar 1 comprimido a noite

BUSCOPAM 10 MG ----- Tomar 1 comprimido de 8 em 8h

DIPIRONA 500 MG ----- Tomar 1 comprimido de 6 em 6h

DOMPERIDONA 10 MG ----- Tomar 1 comprimido de 8 em 8h

OMEPRAZOL 20 MG ----- Tomar 1 comprimido pela manhã

USO ORAL - RECEITAS EM ANEXO

VIMPAT 50 MG ----- Tomar 1 comprimido de 12 em 12h

METADONA 5 MG ----- Tomar 1 comprimido de 12 em 12h

Data de liberação do documento: 15/05/2023 10:52:04

Nome Legível com nº do CRM / Carimbo

Dr. Matheus Marques Franca
CRM-DF:17096





Paciente	Geni Pinheiro da Silva	Atendimento	13.643.294
Nascimento	08/06/1927	Prontuário	2.064.165
Sexo	F	Dt. Entrada	27/04/2023
Convênio	MedSenior - Samedil Serviços de Atendimento Médico SA	Leito	UI332
Médico Responsável	Dr. Carlos Henrique Reis Esselin Rassi (CRM 22575)		

Relatório Médico

Motivo da internação:

- Crise convulsiva em 25/04/2023
- Coleções subdurais bilaterais (hemato-higromas) - tratamento conservador inicial
- Coleção subdural esquerda com efeito compressivo >> PO (30/04/23) Drenagem de coleção subdural esquerda
- Hiponatremia hipolêmica, melhorada pós hidratação
- Leucocitose+ PCR elevado + EAS infeccioso + em contexto de idosa com alt do nível de consciência - ITU?, em tratamento

Antibióticos:

Atual: Rocefin 27/04/2023 a 03/05/23

Culturas:

27/04: Hemoculturas: parciais negativas

27/04: Urocultura: negativa.

Antecedentes pessoais:

- História de hematoma subdural espontâneo prévio- há + 10 anos
- Coledocolitiase há 6 anos > Com internação prolongada, determinando sarcopenia.
- Idosa frágil, com LPP grau II trocântericas
- Relato de uso de puran há anos atrás - filho refere que tinha problema na tireóide - SIC
- Passado de depressão, em contexto de luto (falecimento do marido), filho foi desmamando por conta própria na pandemia, onde perdeu seguimento com médicos, e refere que ela ficou bem de toda forma - SIC.
- Fratura previa em coluna, com tratamento conservador - SIC filho

Funcionalidade prévia:

Totalmente dependente - devido a mobilidade e sarcopenia (transferência com ajuda, ficava sentada 50% do tempo em casa), alimentação supervisionada por filho.

Cognição: Relato de lentificação progressiva, com confusão mental por um período ao acordar, e há 1 ano, com maior dificuldade para memória de curto prazo, mas leve, sem alterações com memória retrógrada. Sem investigação de síndrome demencial a nível ambulatorial e fora de contexto hospitalar.

Planos: Paciente apresenta dor a mobilização no leito, durante a fisioterapia e mobilização no leito, em uso de dipirona e metadona por isso. Aceita a dieta oral assistida. Indicado seguimento domiciliar com foco em medidas de conforto, fisioterapia domiciliar e controle dos sintomas.

Conduta:

- Programação de alta provável hoje - 15/05/23, remoção pelo plano de saúde, com fisioterapia 5x/semana e acompanhamento médico domiciliar.
- Acompanhamento conjunto com ECP.
- Acompanhamento e cuidados multidisciplinares.

Data de liberação do documento: 15/05/2023 10:59:24

Nome Legível com nº do CRM / Carimbo





HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS



13643294

Paciente **Geni Pinheiro da Silva**
Nascimento **08/06/1927**
Sexo **F**
Convênio **MedSenior - Samedil Serviços de Atendimento Médico SA**
Médico Responsável **Dr. Carlos Henrique Reis Esselin Rassi (CRM 22575)**

Atendimento **13.643.294**
Prontuário **2.064.165**
Dt. Entrada **27/04/2023**
Leito **UI332**

Dr. Matheus Marques Franca
CRM-DF:17096





Paciente	Geni Pinheiro da Silva	Atendimento	13.643.294
Nascimento	08/06/1927	Prontuário	2.064.165
Sexo	F	Dt. Entrada	27/04/2023
Convênio	MedSenior - Samedil Serviços de Atendimento Médico SA	Leito	UI332
Médico Responsável	Dr. Carlos Henrique Reis Esselin Rassi (CRM 22575)		

Relatório médico

Motivo da internação:

- Crise convulsiva em 25/04/2023
- Coleções subdurais bilaterais (hemato-higromas) - tratamento conservador inicial
- Coleção subdural esquerda com efeito compressivo >> PO (30/04/23) Drenagem de coleção subdural esquerda
- Hiponatremia hipolêmica, melhorada pós hidratação
- Leucocitose+ PCR elevado + EAS infeccioso + em contexto de idosa com alt do nível de consciência - ITU?, em tratamento

Resumo da internação:

Paciente de 95 anos, encaminhada do PS Medsênior devido a quadro de crise convulsiva há dois dias associado a achado de coleções subdurais bilaterais.

Filho descreve que há pelo 6 anos, devido internação prolongada secundária a complicação de coledocolitíase, paciente ficou mais restrita ao leito, devido a redução de massa muscular, mesmo com fisioterapia, não conseguiu reabilitar completamente. Informa que nos últimos 7 dias paciente vem se apresentando mais apatia e prostração, culminando com crise convulsiva há dois dias.

Durante internação evolui com abordagens clínica e cirúrgica necessárias para o quadro clínico com melhora significativa. Apresenta evolução neurológica favorável e melhor aceitação da dieta via oral, ainda em progressão. Paciente também apresentou melhora do quadro algico, mas ainda mantém alguns episódios de dor relacionados a posição, principalmente no banho, mas com plano de cuidados para ajuste medicamentosos necessários pela equipe de cuidados paliativos da Medsenior. Em programação de alta com seguimento ambulatorial e em casa com a equipe de cuidados paliativos e fisioterapia da medsenior.

Funcionalidade prévia: totalmente dependente (sendo o principal e unico cuidador o filho) - devido a mobilidade e sarcopenia (transferência com ajuda, ficava sentada 50% do tempo em casa), alimentação supervisionada por filho.

Cognição: Relato de lentificação progressiva, com confusão mental por um período ao acordar, e há 1 ano, com maior dificuldade para memória de curto prazo, mas leve, sem alterações com memória retrógrada. Sem investigação de síndrome demencial a nível ambulatorial e fora de contexto hospitalar.

Antecedentes pessoais:

- História de hematoma subdural espontâneo prévio- há + 10 anos
- Coledocolitíase há 6 anos > Com internação prolongada, determinando sarcopenia.
- Idosa frágil, com LPP grau II trocântéricas
- Relato de uso de puran há anos atrás - filho refere que tinha problema na tireóide - SIC
- Passado de depressão, em contexto de luto (falecimento do marido), filho foi desmamando por conta propria na pandemia, onde perdeu seguimento com médicos, e refere que ela ficou bem de toda forma - SIC.
- Fratura previa em coluna, com tratamento conservador - SIC filho

Data de liberação do documento: 15/05/2023 11:35:29

Nome Legível com nº do CRM / Carimbo

Dr. Ronny Thomas O. de Oliveira
CRM-DF: 26138

